

湿疹(eczema)と皮膚炎(dermatitis)

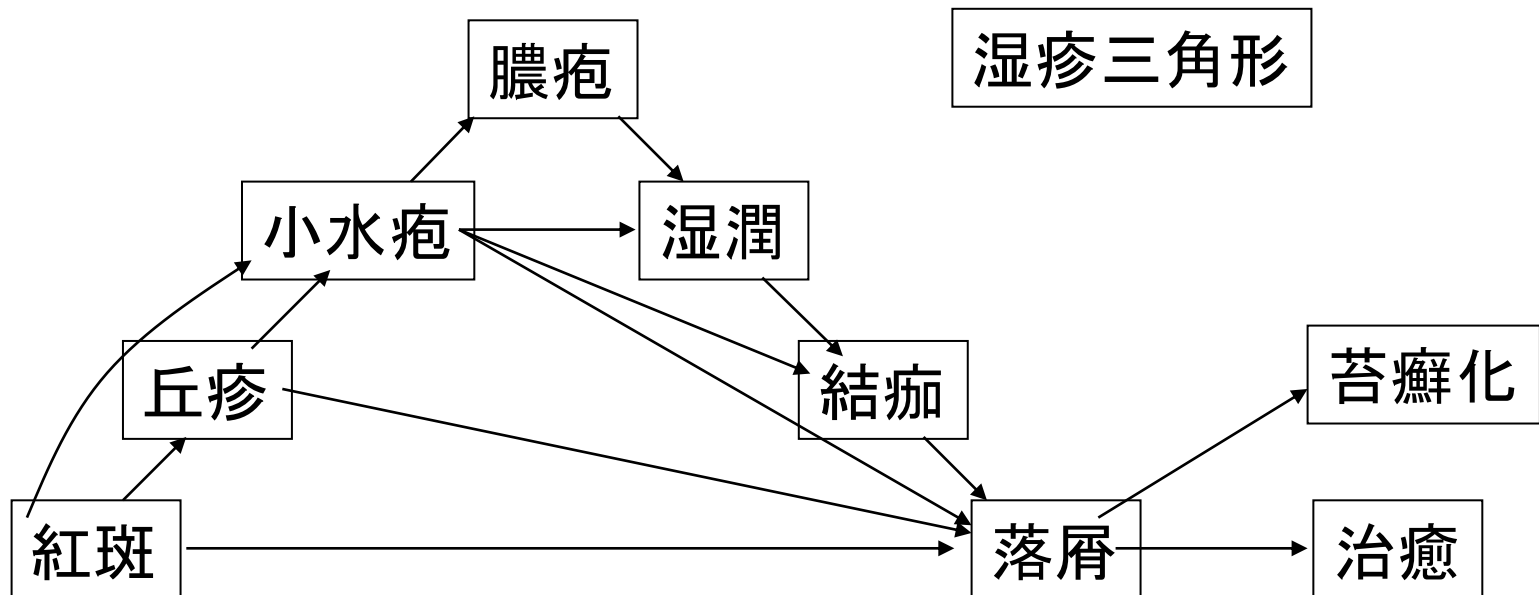
- ・ Willianによって初めて湿疹(eczema)は病名として記載された。
- ・ 元々は異なるとして提唱されたが、現在の考え方では湿疹イコール皮膚炎として両語が用いられている

定義

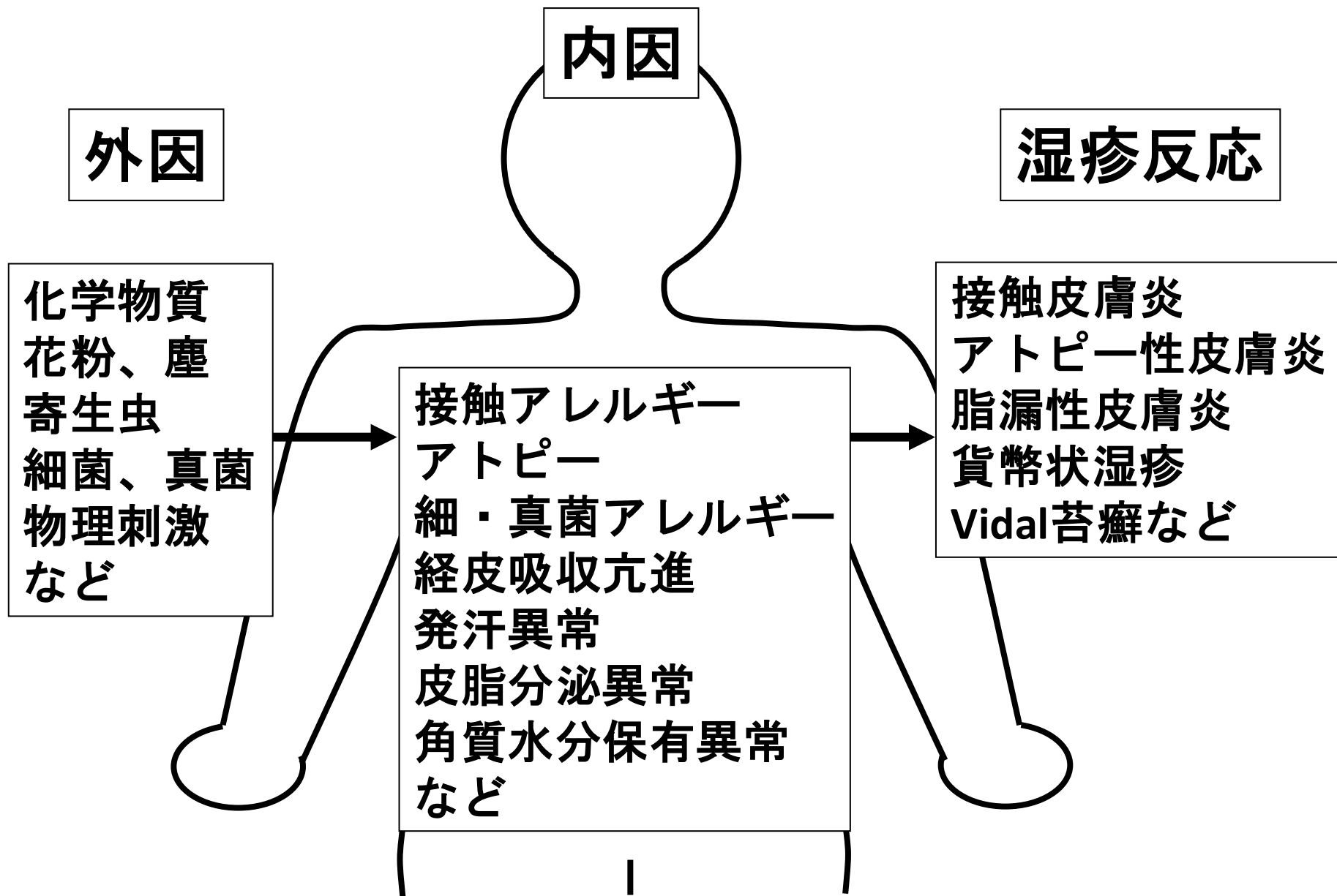
外的、内的刺激に対する表皮・真皮上層を場とし、多少ともかゆみないしヒリヒリ感を伴う無菌性、可逆性の炎症反応であり、組織学的には巣状に生じる表皮の細胞間浮腫、細胞内浮腫から水疱形成に至る基本的特徴を持ち、肉眼的には湿疹三角に示されるように、紅斑、丘疹、小水疱から苔癬化に至る可変性を有する皮疹から成り立つ皮膚疾患の総称である。

湿疹(Eczema)

- ・ 点状状態：小さい点状要素（小水疱・小丘疹・小膿疱・鱗屑など）より成る。
- ・ 多様性：丘疹・小水疱・膿疱・結痂・落屑などを同時に、また時期をちがえて有する。
- ・ 掻痒：必発



湿疹の成り立ち



湿疹の病型

1. 接触皮膚炎 (contact dermatitis)
 - a. 化粧品皮膚炎(cosmetic dermatitis)
 - b. 主婦湿疹、進行性指掌角皮症(housewives eczema)
 - c. おむつ皮膚炎(diaper dermatitis)
 - d. 肛囲皮膚炎(perianal dermatitis)
 - e. 舌なめ皮膚炎(口舐め病)(lick dermatitis)
 - f. 色素沈着型接触皮膚炎(Riehl黒皮症)[pigmented contact dermatitis(melanosia Riehl)]
 - g. 異汗性湿疹(dyshidrotic eczema)
2. アトピー性皮膚炎(atopic dermatitis)
3. 脂漏性皮膚炎(seborrheic dermatitis)
4. Vidal苔癬(lichen simplex chronicus Vidal)
5. 貨幣状湿疹(nummular eczema)
6. 自家感作性皮膚炎(autosensitization dermatitis)
7. うっ滞性皮膚炎(stasis dermatitis)
8. 皮脂欠乏性皮膚炎(asteatotic eczema)

治療

- ・ ステロイド外用
単純塗布

貼付：軟膏を薄く延ばした布を病巣部に貼付する。

密封包帯法(ODT)：外用薬を直接塗布し、この部位を
ポリエチレンフィルムなどで密封する方法。

- ・ 抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬内服

H₁レセプター阻害薬(いわゆる抗ヒスタミン薬)や、肥満細胞からのケミカルメディエーター遊離抑制作用を あわせもつ第2, 第3世代の抗ヒスタミン薬(抗アレルギー薬)の内服が用いられる。

ステロイド外用剤の副作用

内服によるもの

副腎不全、糖尿病、ムーンフェイス、骨粗しょう症など

外用によるもの

- ・ステロイド瘡瘍
 - ・ステロイド潮紅
 - ・皮膚萎縮
 - ・多毛
 - ・乾燥
 - ・接触皮膚炎
 - ・細菌、真菌、ウイルス皮膚感染症など
- (中止あるいは適切な処置により回復する)

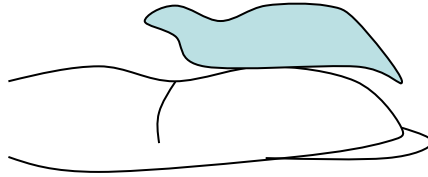
ステロイド外用剤の使用後に色素沈着がみられることがあるが、皮膚炎の鎮静後の色素沈着であり、ステロイド外用剤によるものではない。

抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬

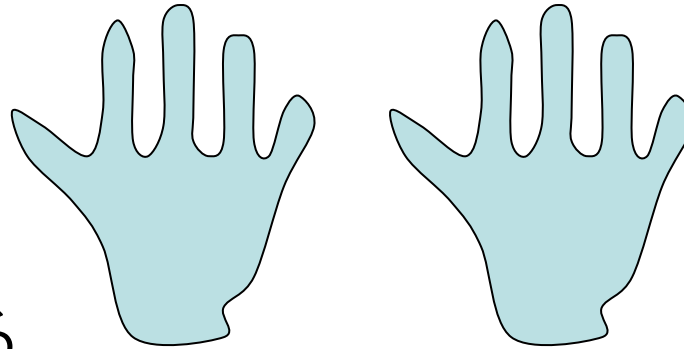
- 苦痛の軽減と痒みによる掻破のための悪化を予防する目的で抗ヒスタミン作用を有する薬剤を使用する(かゆみー掻破ーサイクルの防止)。
- 単独でアトピー性皮膚炎などの炎症を抑制しうるものではないので外用療法との併用が重要。

*ステロイド適正使用量の目安

- ①人差し指の先端から第一関節まで5gチューブから薬剤を出すと0.5g



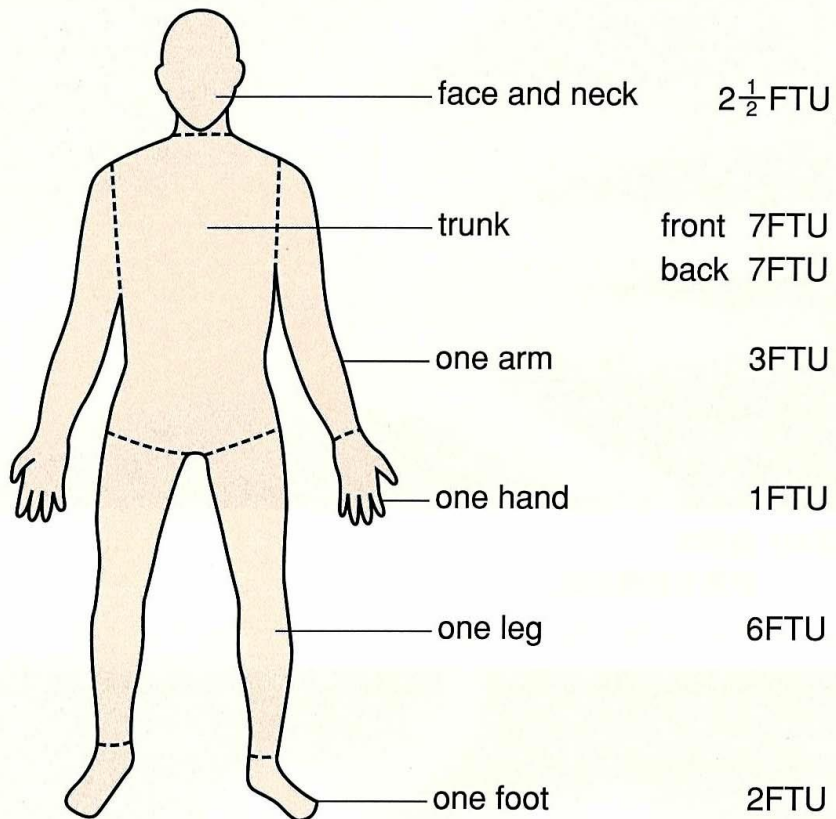
- ②0.5gでは手のひら2つつ分(体表面積2%)の面積を塗ることができる



- ③病変部位を手のひらで測る

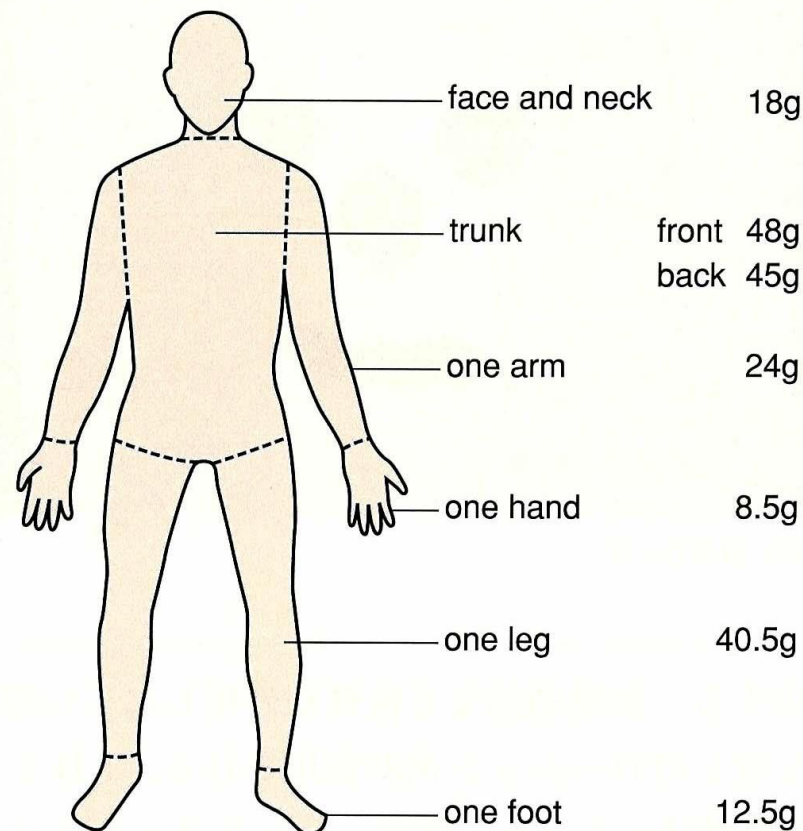
- ④手のひらの10個分(体表面積10%)1回に2.5g(チューブ半分)必要
→2日で1本

軟膏使用量(成人)



軟膏使用量

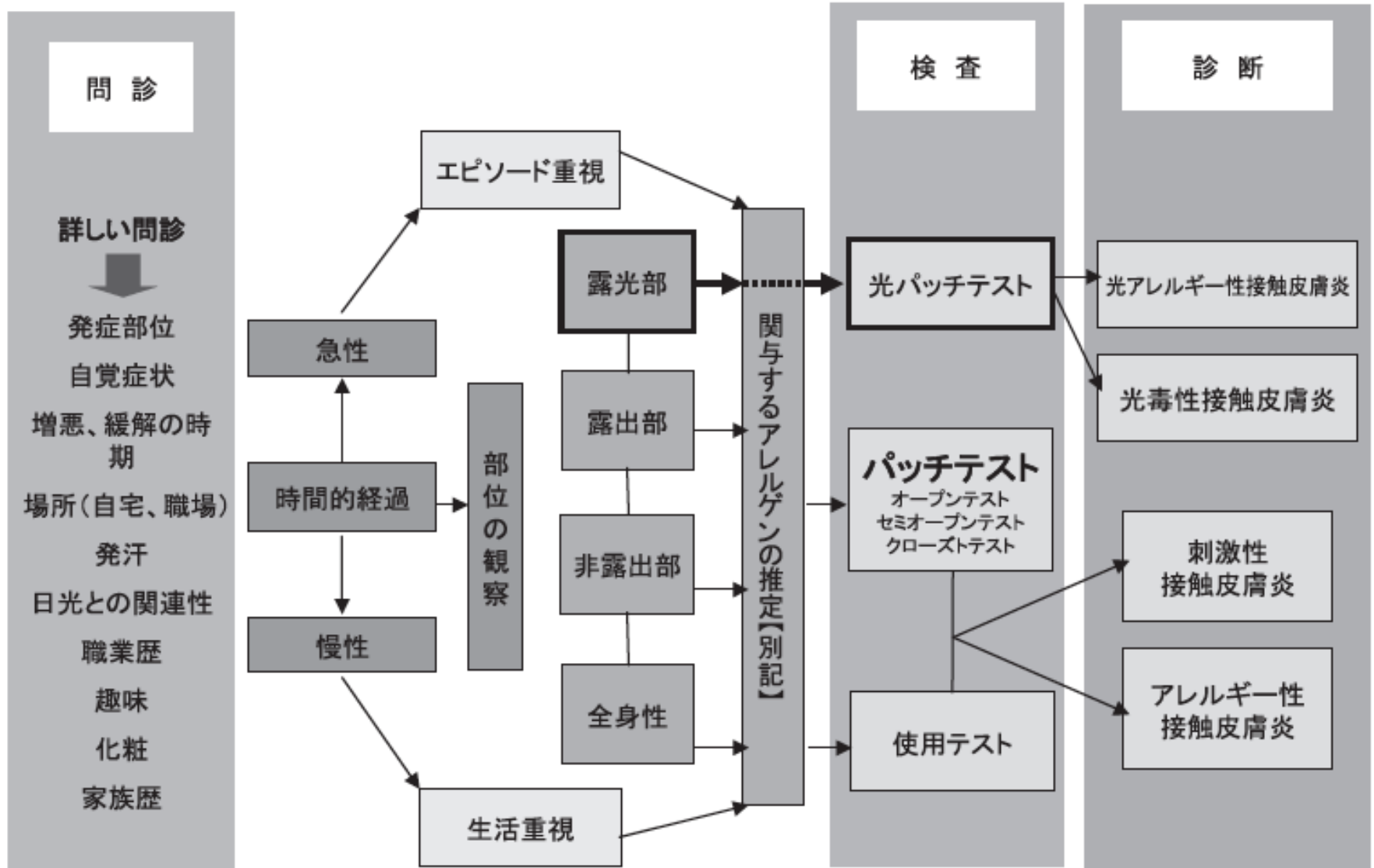
(2回/日、1週間)



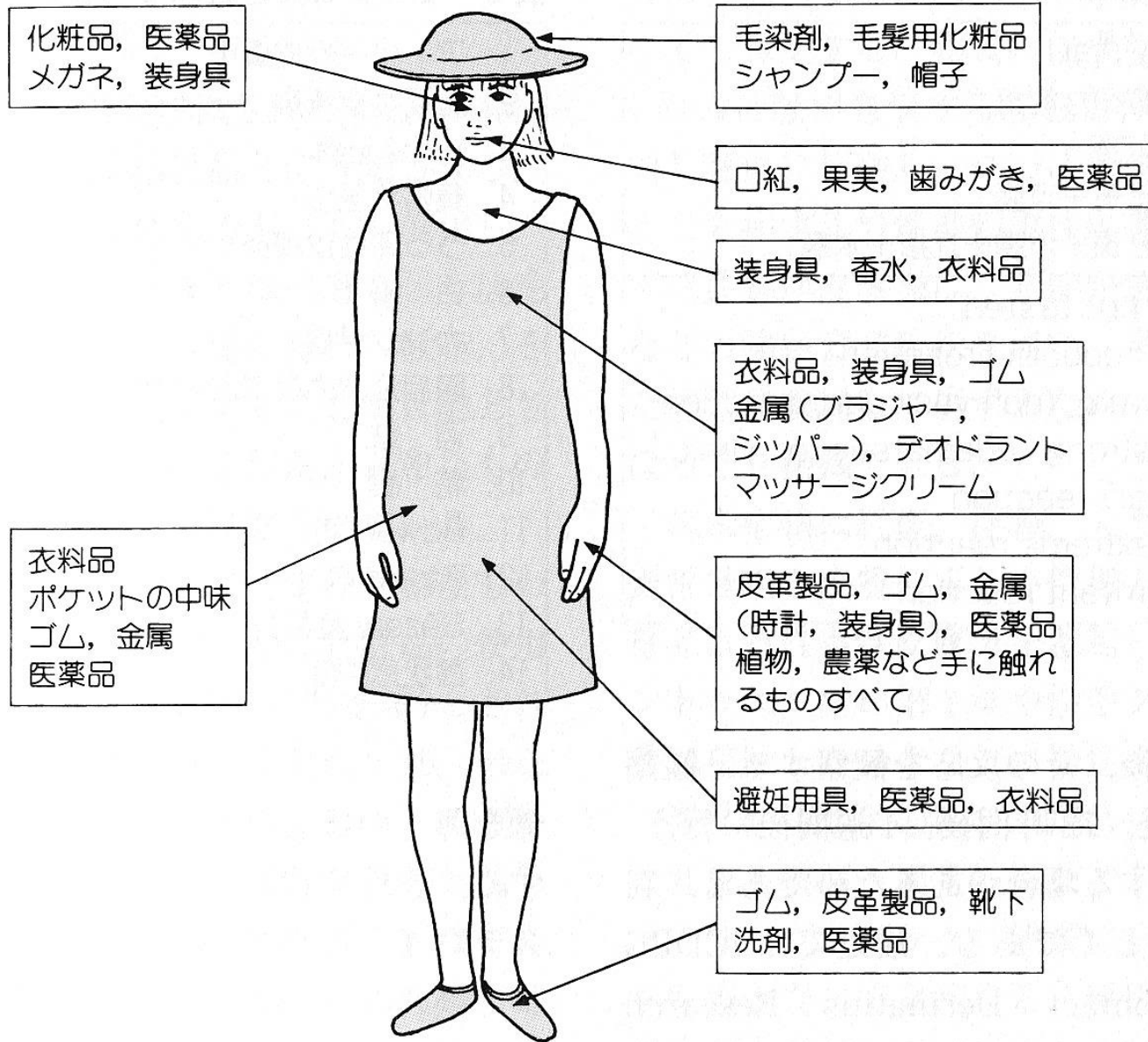
接触皮膚炎

- ・ 一次刺激によるものとアレルギー性のものがある。
 - ①アレルギー性接触皮膚炎、②刺激性接触性皮膚炎、③光アレルギー性接触皮膚炎、④光毒性接触性皮膚炎、⑤接触蕁麻疹の5つに分類される。
- ・ 原因物質は非常に多岐にわたるため詳細な問診が必要。
- ・ 診断確定にはパッチテストが用いられる。
- ・ 原因物質の除去が重要。治療としてはステロイド外用・内服、抗アレルギー薬が用いられる。
- ・ 紫外線暴露が関与することもある。

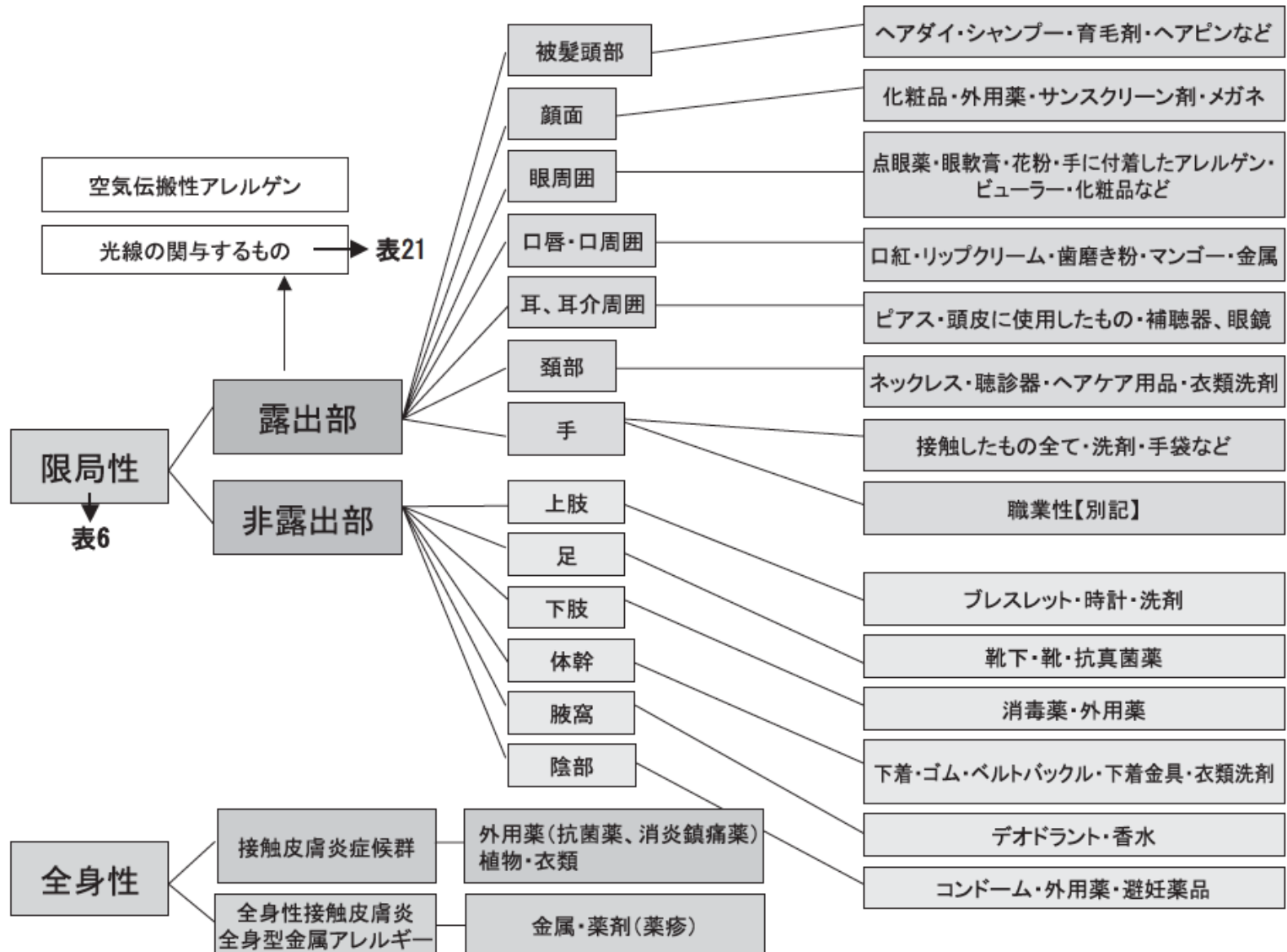
診断の手順



接触皮膚炎の分布と接触原



部位と主な接触原



手湿疹（主婦湿疹）

病態：水仕事の多い人の手に生じる落屑と皮膚の菲薄化に続く湿疹反応で、進行性指掌角皮症・異汗性湿疹なども含まれる。女性に多く、結婚・出産などで水仕事が増えたときに発生しやすく、またアトピー素因がある人に発症しやすい。

症状：手掌・指腹部の潮紅、角質増殖、亀裂などをきたし、手指背では貨幣状湿疹様となることがある。なお、利き手に発症する傾向がある。異汗性湿疹は汗疱の湿疹化したものと考えられているが、掌蹠膿疱症の初期病変の可能性もある。

治療：水仕事を中止し、軽症例では尿素軟膏・白色ワセリン、中等度以上の症例では副腎皮質ステロイド軟膏の外用を行う。

おむつ皮膚炎

おむつのあたる部位に紅斑、ときに漿液性丘疹・びらんを生じるもので、尿・便の刺激、、おむつの機械的刺激、密閉環境などによる。カンジダ症との鑑別が重要である。

脂漏性皮膚炎

- ・ 脂漏部位・間擦部に生じる鱗屑を伴う慢性皮膚炎。
被髪頭部（特に生え際）・耳介とその周囲、外耳道・顔面・腋窩・正中線部・臍窩・外陰部などの脂漏部位に細かい鱗屑と紅斑を生じる。
- ・ 常在好脂性真菌である癬菌の関与がいられている。
- ・ 基本的には慢性・再発性である。
- ・ 被髪頭部ではステロイドローションの使用、顔面ではマイルドクラス（Ⅳ群）のステロイドを用い、炎症がおさまったら外用を中止したり、抗真菌薬外用へ変更する。

生活指導のポイント

- 疲労・ストレス・暴飲暴食・寝不足などを避ける。
- 石けんによる洗顔・洗浄やシャンプーによる洗髪を勧める。
- シャンプーの後はドライヤー等で早めに乾燥させる。
抗真菌剤配合シャンプーなどが有効はことがある。

貨幣状湿疹

症状：四肢伸側・腰部・殿部に撒布される類円形(貨幣状あるいはコイン状)の湿疹局面で、強いかゆみを伴う。漿液性丘疹・湿潤・痂皮・落屑などが混在し、重症例では分泌物を伴う。中年以降に発症することが多く、掻破によって増悪し、しばしば自家感作性皮膚炎の原発巣となる。

自家感作性皮膚炎

症状： 原発巣となる皮疹が急性増悪し、他の皮膚に撒布性に小さな皮疹(撒布疹)が急速に多発する状態である。

原発巣は貨幣状湿疹・接触皮膚炎・うっ滞性皮膚炎・下腿潰瘍など滲出傾向の強い湿疹病変で、下腿に好発する。

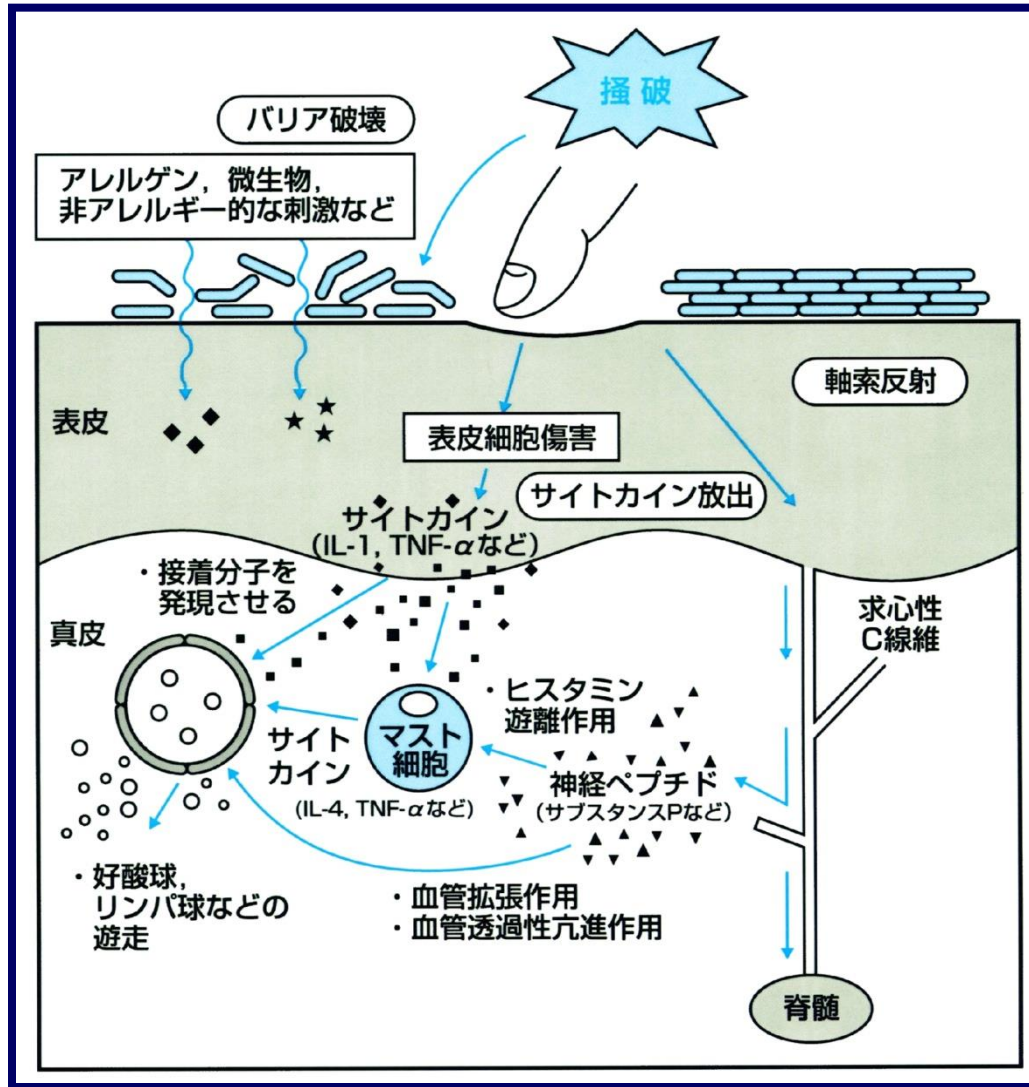
撒布疹は小型の紅斑・丘疹・漿液性丘疹で、皮疹は体幹・四肢近位部に多く見られ、瘙痒が著しい。放置すれば個々の皮疹は成長し、貨幣状湿疹様となる。

治療： 湿疹・皮膚炎の治療に準じるが、症状が激しい場合は短期間のステロイド内服も行われる。なお、先行病巣の適切な治療も大切である。

皮脂欠乏性湿疹

- ・ 季節などにより角層の水分量が減少し、皮膚が乾燥・粗造化した状態を乾皮症という。
- ・ 痒みのために掻破を繰り返し湿疹化したものを皮脂欠乏性湿疹という。
- ・ 下腿伸側・腰背部などに好発する。
- ・ 保湿剤・抗アレルギー薬・ステロイド外用剤を用いる。
併せて、生活指導を行う。

ドライスキンに基づく皮膚過敏性



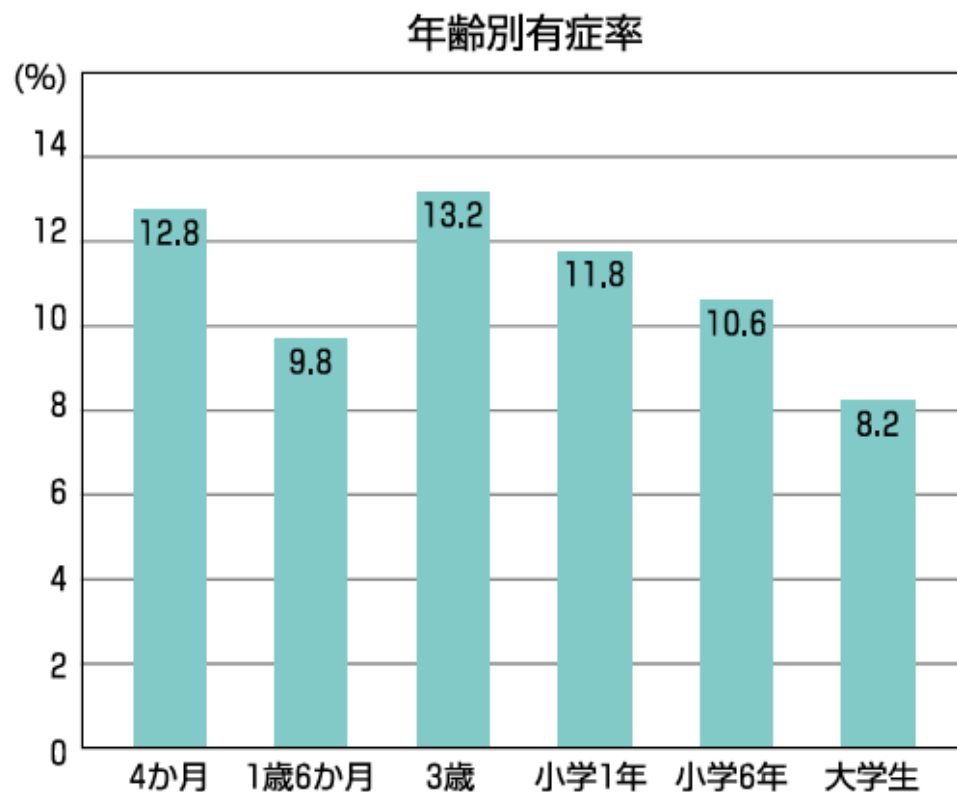
掻破はバリア機能を破壊し、炎症の惹起や肥満細胞活性化等、病変を増悪させ悪循環を引き起こす。

生活指導のポイント

- 入浴温度は40～42℃くらいで、低い方がよい。
長湯はしない。
- 石けんの使用回数を減らし、タオル等で擦らない。
- 下着は綿など低刺激のものを着用する。
- 電気毛布は乾燥、かゆみの原因になるので注意。
- 痒いときは、飲酒や辛いものの摂取に注意。
- 入浴剤はムトウハップなど硫黄の入ったものは避ける。
- 保湿剤などの外用は、入浴後15分以内に行う。

アトピー性皮膚炎の有症率

我が国の本症有症率（全国8地区平均）



●4か月

北海道、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の7地区

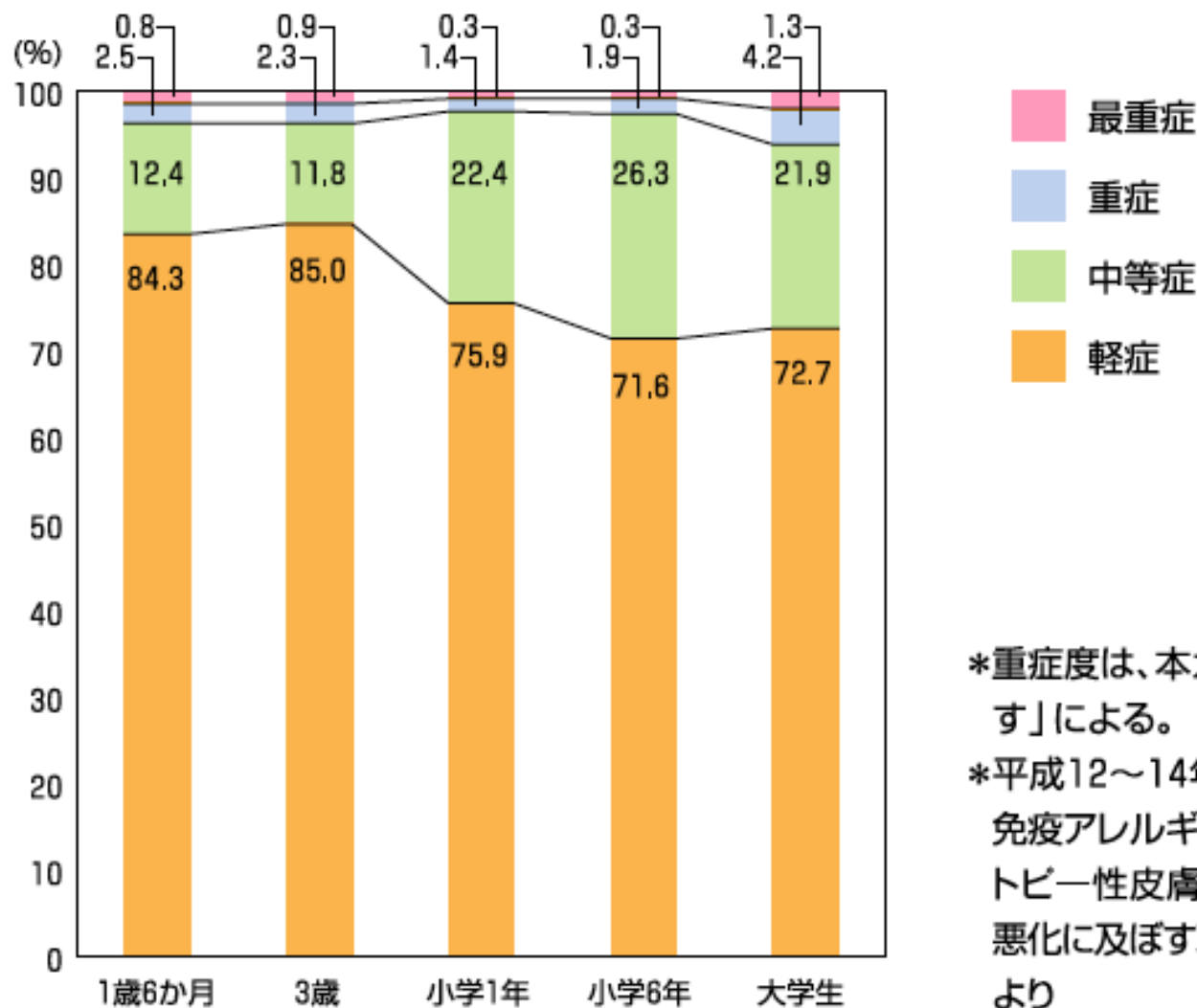
●1歳6か月、3歳、小学1年、小学6年

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8地区

●大学生

東京大学、近畿大学、広島大学の3大学

重症度別割合



*重症度は、本ガイドラインの「重症度のめやす」による。

*平成12～14年厚生労働科学研究費補助金
免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業「アトピー性皮膚炎の患者数の実態及び発症・悪化に及ぼす環境因子の調査に関する研究」より

アトピー : 「奇妙な」「とらえどころない」

1933年に米国のSultzbergerにより
提唱された。

- | | |
|-------------|--------------|
| ・内因性湿疹 | ・Besnier痒疹 |
| ・乳児顔面頭部急性湿疹 | ・小児湿疹乾燥型 |
| ・乳児湿疹性湿疹 | ・局面性苔癬様落屑性湿疹 |
| ・幼小児屈側苔癬化湿疹 | ・単純性粒糠疹 |
| ・晩発性浸出性類湿疹 | |

アトピー性皮膚炎の定義

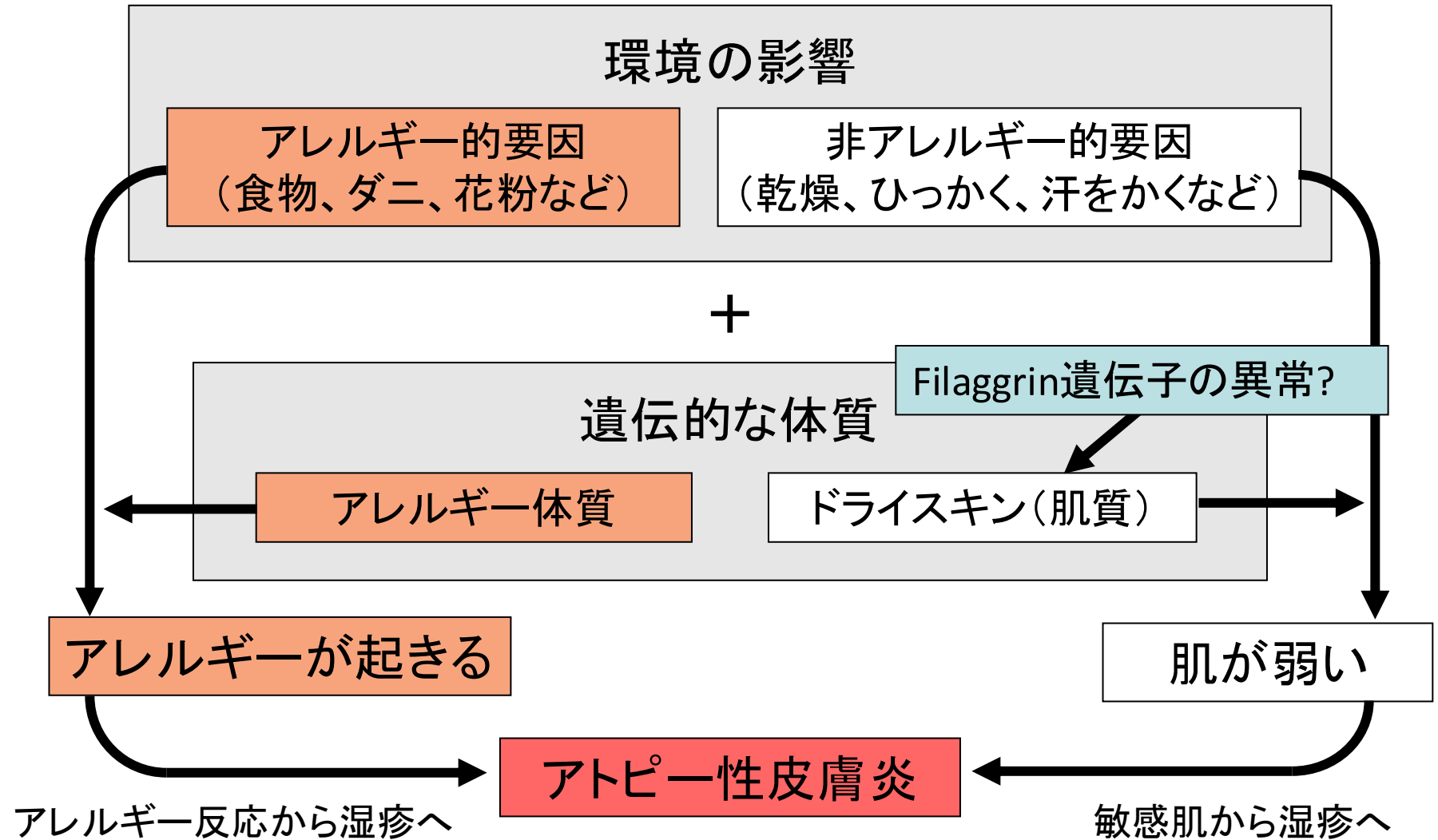
アトピー性皮膚炎は、増悪・寛解を繰り返す、掻痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー素因をもつ。

アトピー素因：①家族歴・既往歴（気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれか、あるいは複数の疾患、または②IgE抗体を産生しやすい素因

アトピー性皮膚炎とは？

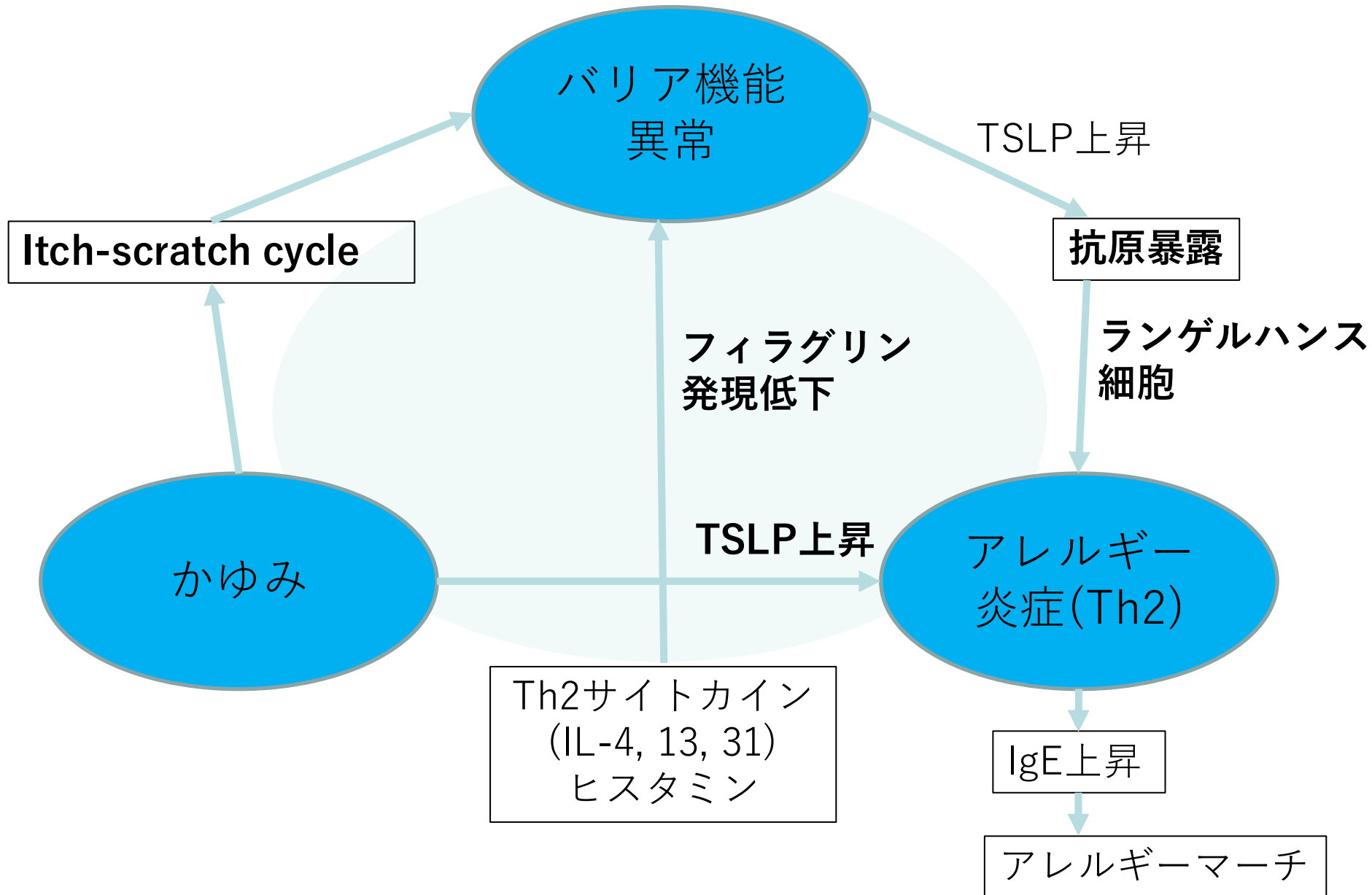
痒みを伴い慢性的に経過する皮膚炎（湿疹）ですが、その根本には皮膚の生理学的異常（皮膚の乾燥とバリアー機能異常）があり、そこへ様々な刺激やアレルギー反応が加わって生じると考えられています。慢性的ではありますが、適切な治療をきちんと受ければ、いずれ治ったと同然の状態になることが期待されます。

アトピー性皮膚炎の発症機序



アレルギー機序と非アレルギー機序が等しく重要である。

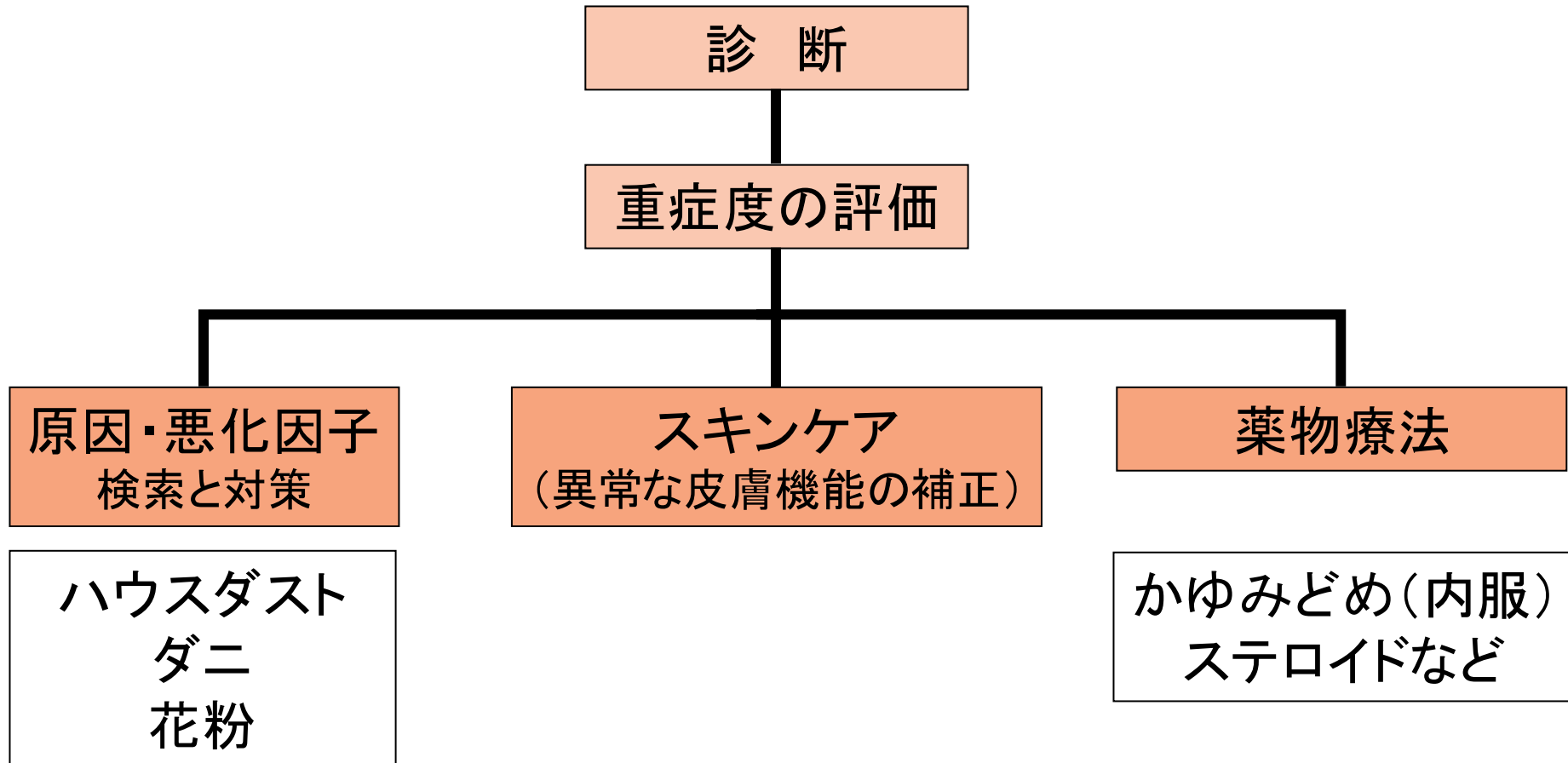
アトピー性皮膚炎発症における三位一体論



治療の目標

1. 症状はないか、あっても軽く、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない。
2. 軽い症状は続くが、急激に悪化することはまれで、悪化しても持続しない。

治療の流れ



スキンケアが治療の3本柱の一翼を担う。

TARC

(Thymus and Activation-Regulated Chemokine)

- アレルギー炎症を惹起するリンパ球（CCR4を発現したTh2細胞）を患部へ遊走させ症状を増悪させる。
- アトピー性皮膚炎のモニタリングに有用（皮膚症状の変化を反映する）。
- アトピー性皮膚炎の重症度を反映する。

参考基準範囲(健常者)

小児(6ヶ月以上12ヶ月未満) ¹⁾	1367 pg/mL 未満
小児(1歳以上2歳未満) ¹⁾	998 pg/mL 未満
小児(2歳以上) ¹⁾	743 pg/mL 未満
成人 ²⁾	450 pg/mL 未満

2歳未満における年齢と血清TARC値の関係に基づく期待値の95%信頼区間
成人及び2歳以上の小児において得られた平均値+1.96σ

アトピー性皮膚炎の重症度判定の目安

小児(2歳以上) ¹⁾	軽症 <760 pg/mL ≤ 中等症以上
成人 ²⁾	軽症 <700 pg/mL ≤ 中等症以上

成人アトピー性皮膚炎の軽症群(n=64)と中等症群(n=89)及び小児(2歳以上)アトピー性皮膚炎の軽症群(n=25)と中等症群(n=23)について、血清TARC値を用いたROC解析からカットオフ値を求め、アトピー性皮膚炎重症度判定のひとつの目安とした。

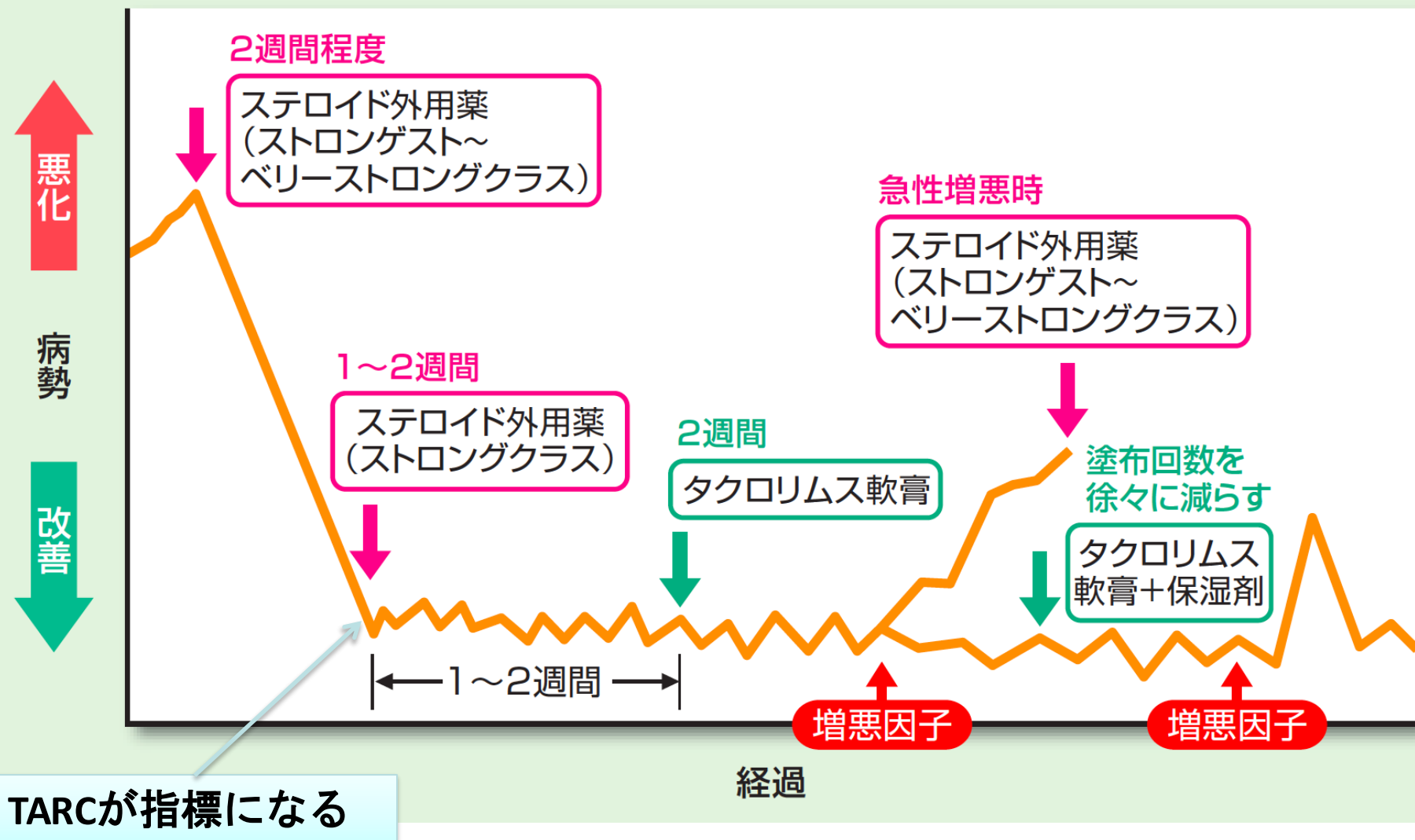
1) 藤澤隆夫ほか:日本小児アレルギー学会誌, 19(5), 744(2005)より引用

2) 玉置邦彦ほか:日本皮膚科学会雑誌, 116(1), 27(2006)より引用

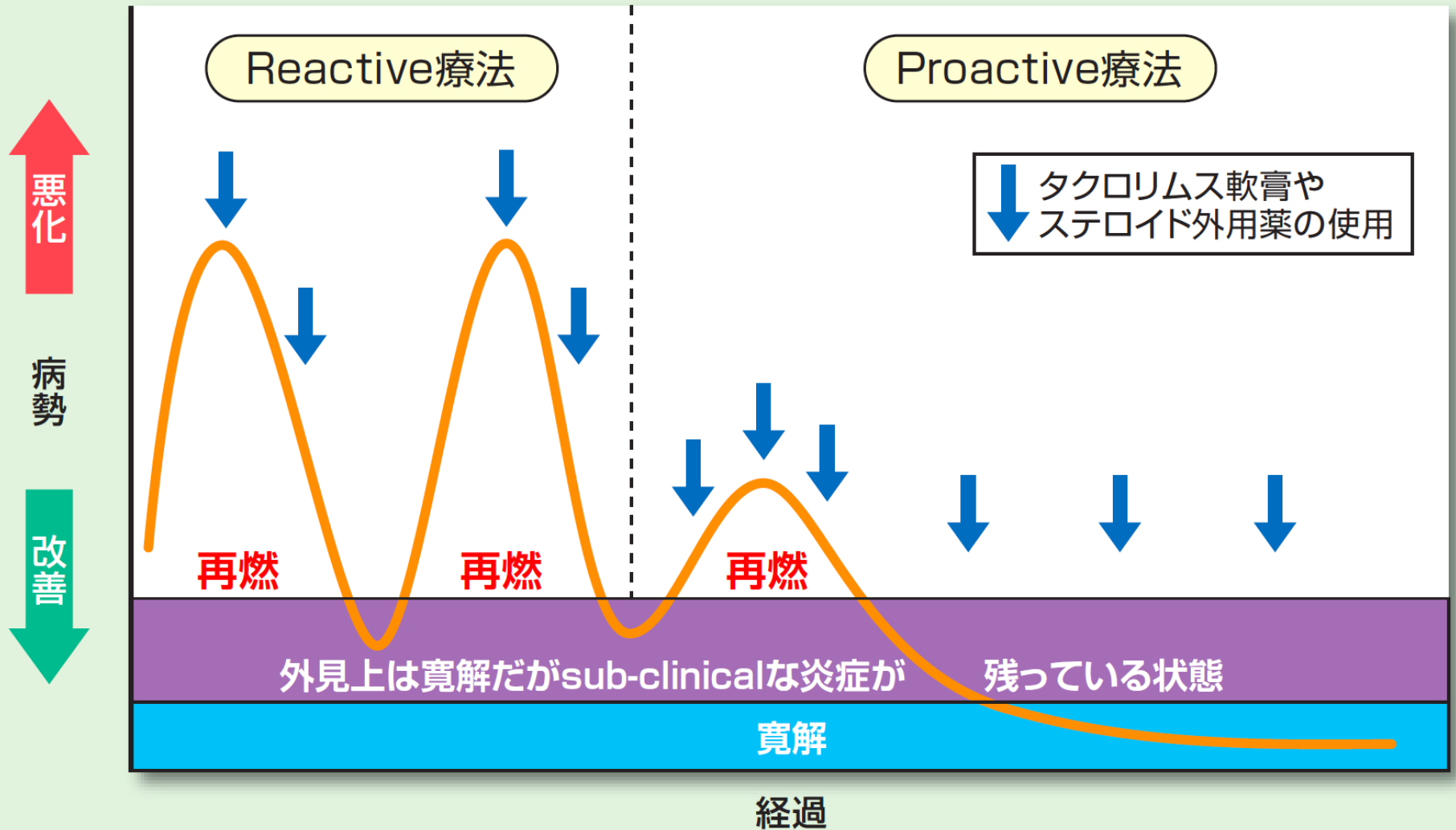
薬物療法の種類

1. ステロイド外用
2. 免疫調整剤外用（タクロリムス）
3. ステロイド内服
4. 免疫抑制剤内服（シクロスポリン）
5. 抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬内服
6. 漢方
7. 生物製剤（デュピルマブなど）
8. JAK阻害薬（外用、内服）
9. その他（PDE4阻害薬外用、AhR調整薬外用）

ADの治療ストラテジー（躯幹、四肢）



Proactive療法



皮疹の重症度と外用薬の選択

重症度のめやす

軽症 : 面積にかかわらず、軽度の皮疹が認められる

中等症 : 強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10%未満

重症 : 強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10%以上、30%未満

最重症 : 強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30%以上



薬物療法の基本例にしたがい選択する

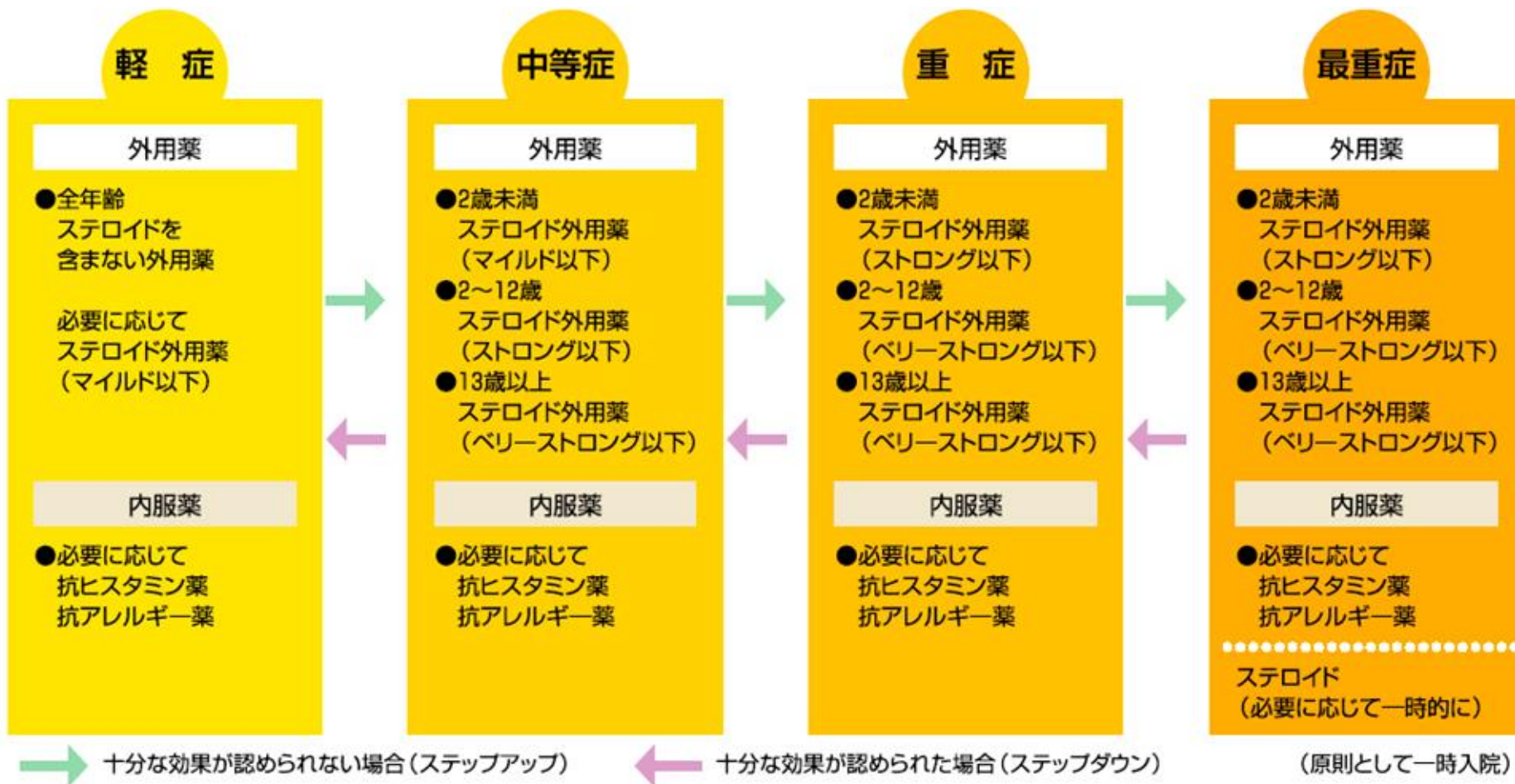
(厚生労働科学研究「アトピー性皮膚炎治療ガイドライン2005」より引用、改変)

皮疹の重症度と 外用剤の選択

皮疹の重症度		外用薬の第一選択薬
軽微	炎症症状に乏しい乾燥症状主体	ステロイドを含まない外用薬
軽症	乾燥、および軽度の紅斑、鱗屑	ミディアム(マイルド)以下のステロイド外用薬
中等症	中等症までの紅斑、鱗屑、少数の丘疹、掻破痕など	ストロングないしミディアム(マイルド)クラスのステロイド外用薬
重症	高度の腫脹／浮腫／浸潤ないし苔癬化を伴う紅斑、丘疹の多発、高度の鱗屑、痂皮、小水疱、びらん、多数の掻破痕、痒疹結節	ベリーストロングないしストロンゲストクラスのステロイド外用薬。痒疹結節では効果が得られない場合、その部位に限定してストロンゲストクラスの使用もある。

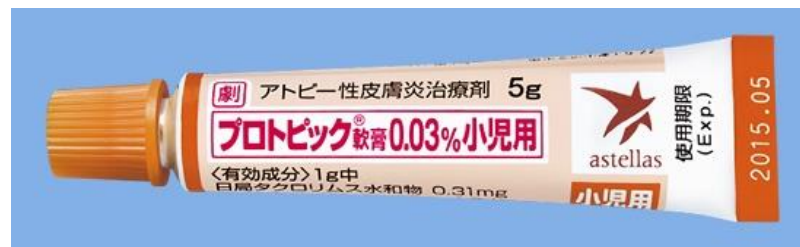
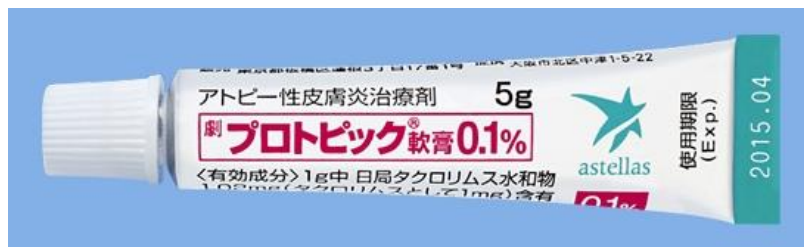
(古江増隆他「日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎治療ガイドライン2003」より引用、改変)

薬物療法の基本例



タクロリムス（プロトピック）軟膏

- ・ 1999年11月、アトピー性皮膚炎治療薬として日本で発売。
- ・ 現在では0.1%のものが16歳以上に、0.03%のものが2～15歳の小児に認可されている。
- ・ 1984年に筑波山麓の土壌から分離された放線菌の代謝産物から発見され、内服・注射では免疫抑制剤として使用されている。
- ・ 外用剤では免疫調整薬に分類される。



プロトピック軟膏の特徴

- ・Ⅲ群のステロイドと同等の抗炎症作用を有し、皮膚萎縮の副作用がないため、顔面、頸部の皮疹に対して特に有用性が高い。
- ・使用開始時に、大部分の症例で何らかの刺激症状を訴える。
- ・刺激感は皮膚症状の改善とともに1週間以内に減弱または消失することが多い。
- ・分子量が約800と大きいいため、皮膚から全身へ吸収されにくい吸収されない。
- ・使用量に制限がある。

2～5歳	(20 kg未満)	1g /回
6～12歳	(20～50 kg)	2～4g /回
13歳以上	(50 kg以上)	5g /回
1日2回まで		

小児用(2～15歳)0.03%
成人用(16歳以上)0.1%

- ・妊娠（授乳）中には禁忌ではなくなった（2018年7月）。
- ・強い紫外線を浴びる状況では、使用しないように指導されている。
- ・プロアクティブ療法として用いられつつある。

その他の治療

- デュピクセント（IL-4/IL-13のシグナル伝達の阻害）
- JAK阻害剤（外用薬、内服薬が承認）
- 免疫抑制剤内服（シクロスポリン）
- 光線療法（PUVA、ナローバンドUVB、UVA1など）
- 漢方薬（消風散、補中益気湯など）

今後、期待される治療

- 生物製剤
- かゆみ、乾燥に対する新規薬剤の開発

スキンケアの実際

1. 皮膚の清潔

毎日の入浴・シャワー

- ・汚れは速やかにおとす。しかし、強くこすらない。
- ・石鹸・シャンプーを使用するときは洗浄力の強いものは避ける。
- ・石鹸・シャンプーは残らないように十分すすぐ。
- ・痒みを生じるほどの高い温度の湯は避ける。
- ・入浴後にほてりを感じさせる沐浴剤・入浴剤は避ける。
- ・患者あるいは保護者には皮膚の状態に応じた洗い方を指導する。
- ・入浴後には、必要に応じて適切な外用薬を塗布する。 など

2. 皮膚の保湿・保護

保湿・保護を目的とする外用薬

- ・保湿・保護を目的とする外用薬は皮膚の乾燥防止に有用である。
- ・入浴・シャワー後には必要に応じて保湿・保護を目的とする外用薬を塗布する。
- ・患者ごとに使用感のよい保湿・保護を目的とする外用薬を選択する。
- ・軽微な皮膚炎は保湿・保護を目的とする外用薬のみで改善することがある。 など

3. その他

- ・室内を清潔にし、適温・適湿を保つ。
- ・新しい肌着は使用前に水洗いする。
- ・洗剤はできれば合成界面活性剤の含有量の少ないものを使用する。
- ・爪を短く切り、なるべく搔かないようにする。
(手袋や包帯による保護が有用なことがある) など

生活指導

- 入浴、シャワーにより皮膚を清潔に保つ。
- 室内を清潔に保ち、適温・適湿の環境を作る。
- 規則正しい生活をおくり、暴飲・暴食は避ける。
- 刺激の少ない衣服を着用する。
- 爪は短く切り、掻破による皮膚障害を避ける。
- ステロイド外用剤の使用によるためでなく、眼囲の皮疹を掻破、叩打により眼病変（白内障、網膜裂孔、網膜剥離）を生じうることに留意し、顔面の症状が高度な例では眼科医の診察を定期的に受ける。
- 細菌・真菌・ウイルス性皮膚感染症を生じやすいので、皮膚をよい状態に保つよう留意する。